

# Guide d'administration

## Protocole Vinorelbine

Rédaction : juin 2015

Révision : juin 2015

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

### 1. Application thérapeutique

---

Traitement du cancer du sein métastatique<sup>1,2</sup>.

Visée palliative.

### 2. Guide d'administration

---

#### 2.1. Description du protocole

La vinorelbine est administrée jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable<sup>1</sup>.

Différents régimes d'administration sont utilisés :

- › 1 fois par semaine à toutes les semaines<sup>1</sup>

*OU*

- › aux jours 1 et 8 d'un cycle de 21 jours<sup>2,3</sup>

En clinique externe.

#### 2.2. Schéma d'administration<sup>1-3</sup>

| Médicament  | Dose                   | Description                                                    |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Vinorelbine | 30 mg/m <sup>2</sup> * | › IV dans 50 ml de NaCl 0,9 % en 6 à 10 minutes <sup>4**</sup> |

*Répéter le traitement 1 fois par semaine à toutes les semaines*

*OU*

*Aux jours 1 et 8 d'un cycle de 21 jours*

Considérations spéciales :

\*Une dose de départ de 25mg/m<sup>2</sup> a été administrée chez des patientes en troisième intention de traitement<sup>2</sup>.

\*\*En périphérie, on utilise une voie primaire de dextrose 5 % ou NaCl 0,9 % à haut débit lors de l'administration d'un agent vésicant<sup>5</sup>. Après l'injection du médicament, bien rincer la veine avec 75-125 ml de soluté<sup>4</sup>.

## 2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation** : aucune au préalable.
- › **Anti-émétiques**<sup>6</sup> : potentiel très faiblement émétisant (< 10 %) ;
  - Pré-chimiothérapie : aucun.
  - Post-chimiothérapie : prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin.
- › **Irritation et douleur au site d'injection**<sup>4,5</sup> :
  - L'administration de la vinorelbine en bolus de 6-10 minutes diminue l'incidence de cet effet secondaire. Bien rincer la veine après l'administration avec 75 à 125 ml de soluté.
- › **Douleur au site de la lésion tumorale**<sup>7,8</sup> :
  - Apparaît généralement 30 minutes après l'administration de la première dose de vinorelbine. Cette douleur est d'une durée variant de 1 heure à 2 jours. Les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, les corticostéroïdes et les opiacés peuvent aider au soulagement de ces symptômes.
- › **Surveillance de la constipation**<sup>9</sup> :
  - La constipation accompagnée de douleurs abdominales peut être présente avec la vinorelbine.
  - Prescription d'un laxatif et d'un agent émollient si besoin.

## 3. Guide d'ajustement posologique

---

### 3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale<sup>10</sup>

| Médicament  | Ajustement posologique recommandé |
|-------------|-----------------------------------|
| Vinorelbine | Aucun ajustement requis           |

### 3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique<sup>1,10</sup>

| Médicament  | Ajustement posologique recommandé        |
|-------------|------------------------------------------|
| Vinorelbine | Bilirubine ≤ 35 µmol/L = 100% de la dose |
|             | Bilirubine 36-50 µmol/L = 50% de la dose |
|             | Bilirubine > 50 µmol/L = 25% de la dose  |

### 3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique<sup>1</sup>

| Neutrophiles<br>(X 10 <sup>9</sup> /L) |    | Plaquettes<br>(X 10 <sup>9</sup> /L) | Ajustement posologique recommandé*                                       |
|----------------------------------------|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ≥ 1,5                                  | OU | ≥ 100                                | 100% de la dose de départ<br>75% de la dose pour les patients à risque** |
| 1,0-1,49                               | OU | 75-99                                | 50% de la dose de départ                                                 |
| < 1,0                                  | OU | < 75                                 | Retarder le traitement d'une semaine                                     |

\*Les ajustements peuvent varier selon les références consultées.

\*\*Patient à risque : ayant développé fièvre et/ou sepsis avec neutropénie ou interruption de traitement pendant 2 semaines consécutives à cause de neutropénie.

### 3.4. Ajustement des doses en cas de neuropathie périphérique<sup>1</sup>

| Grade* | Description                                                                                       | Ajustement posologique recommandé                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Paresthésie ne perturbant pas la fonction, perte de réflexes.                                     | 100% de la dose.                                                                       |
| 2      | Paresthésie perturbant la fonction mais non les activités, difficulté à attacher des boutons.     | Reporter le traitement d'une semaine jusqu'au retour à un grade 1.                     |
| 3      | Perte sensorielle perturbant les activités de la vie quotidienne, neuropathies motrices modérées. | Selon le jugement clinique, une réduction de dose pourrait également être envisagée**. |
| 4      | Neuropathies motrices sévères entraînant une incapacité.                                          |                                                                                        |

\*NCI CTCAE version 3.

\*\*Ces recommandations sont basées sur un consensus d'expert.

## 4. Monitoring

### 4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** est fréquente et peut être dose-limitante. Elle dure habituellement de 7 à 14 jours et survient le plus souvent lors de la 3<sup>e</sup> semaine du traitement hebdomadaire<sup>1,11</sup>. L'anémie est fréquente. La thrombocytopénie est quant à elle plutôt rare<sup>4,11,12</sup>.

Les **nausées** sont généralement de faible intensité et bien contrôlées avec la médication anti-émétique (voir [section 2.3- Thérapie de support](#))<sup>6</sup>.

L'**asthénie** est très fréquente en cours de traitement<sup>1</sup>.

Des **neuropathies périphériques** sont possibles avec la vinorelbine quoique moins fréquentes que celles associées à la vincristine<sup>1</sup>. Elles surviennent en fonction de la dose cumulative. Elles se manifestent principalement par la perte des réflexes tendineux profonds, des paresthésies et des hypoesthésies. Elles sont lentement réversibles et dans certains cas irréversibles<sup>13</sup>. Un délai de traitement et ou une diminution de dose sont recommandés en présence d'une toxicité modérée ou sévère (voir [section 3.4- Ajustement des doses en cas de neuropathie périphérique](#)).

La **constipation** peut être sévère avec la vinorelbine et des cas d'iléus ont été rapportés<sup>14</sup> (voir [section 2.3- Thérapie de support](#)).

L'**irritation veineuse** (phlébite) est fréquente et se présente comme une sensation de brûlure au site d'injection et de serrement le long de la veine près du site. Cette réaction est plus fréquente avec l'administration en perfusion de 20 à 30 minutes. C'est pourquoi l'administration en bolus (6-10 min.) via la tubulure d'un soluté est recommandée. L'insertion d'une voie centrale permet d'éviter cet effet indésirable<sup>11,12</sup>. L'application de chaleur et le rinçage de la tubulure avant et après l'administration avec du soluté physiologique peut diminuer l'inconfort<sup>12</sup>. Dans la pratique clinique, un corticostéroïde (p.ex.: l'hydrocortisone 100mg IV ou la dexaméthasone IV) peut être administré avant l'infusion de vinorelbine chez les patients avec une voie périphérique présentant de l'irritation veineuse<sup>15</sup>.

La **dyspnée aiguë** et le **bronchospasme** sont des réactions sévères mais rares qui s'apparentent à une réaction allergique et pouvant répondre à l'administration de broncho-dilatateurs. Une réaction subaiguë peut également survenir se présentant par de la toux, de la dyspnée, de l'hypoxémie et une infiltration interstitielle. Cette réaction pulmonaire peut répondre à une corticothérapie et l'administration d'oxygène peut soulager les symptômes<sup>4</sup>.

La vinorelbine est **vésicante** pour les veines (extravasation)<sup>5</sup>.

L'alopécie n'est pas fréquente et est généralement partielle<sup>12</sup>.

Tableau des effets indésirables<sup>1</sup> :

| Effet indésirable       | Incidence globale (%) | Grade 3 et 4 (%) |
|-------------------------|-----------------------|------------------|
| Leucopénie              | 99                    | 60               |
| Nausées                 | 56                    | 2                |
| Asthénie                | 49                    | 11               |
| Constipation            | 38                    | 5                |
| Réaction site injection | 28                    | 2                |
| Vomissement             | 26                    | 2                |
| Anorexie                | 25                    | 0                |
| Diarrhée                | 21                    | <1               |
| Paresthésie             | 18                    | 0                |
| Stomatite               | 13                    | 0                |

## 4.2. Interactions cliniques significatives

La **vinorelbine** est un substrat majeur du CYP450 3A4, mineur du CYP450 2D6. C'est également un faible inhibiteur des CYP450 2D6 et 3A4<sup>10</sup>.

| Interaction                                                                                                           | Effet                                                                 | Conduite suggérée                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4</b> (p. ex. : kétoconazole, itraconazole, clarithromycine, posaconazole, etc.) | ↑ des concentrations de vinorelbine.<br><br><i>Sévérité : Majeure</i> | Éviter la co-administration.<br><br>Surveiller les signes de toxicité (neuropathies, diminution du péristaltisme). |
| <b>Inducteurs puissants du CYP450 3A4</b> (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)         | ↓ des concentrations de vinorelbine.<br><br><i>Sévérité : Majeure</i> | Éviter la co-administration.                                                                                       |
| Vaccins vivants                                                                                                       | Risque de développer une infection.<br><br><i>Sévérité : majeure</i>  | Éviter la co-administration.                                                                                       |

## 4.3. Suivi de laboratoire

|                   | Labos pour ajustements des doses |
|-------------------|----------------------------------|
| Bilan de BASE     | FSC, bilirubine, AST, ALT        |
| Avant chaque dose | FSC, bilirubine, AST, ALT        |

## 5. Références

1. Weber B, Vogel C, Jones S. et al. Intravenous Vinorelbine as First-Line and Second-Line Therapy in Advanced Breast Cancer. J Clin Oncol 1995; 13(11): 2722-2730.
2. Toi M, Saeki T, Aogi K et al. Late phase II clinical trial of vinorelbine monotherapy in advanced or recurrent breast cancer previously treated with anthracyclines and taxanes. Jpn J clin Oncol 2005; 35(6): 310-15.
3. Teranziani M, Demicheli R, Brambilla C et al. Vinorelbine: an active, non cross-resistant drug in advanced breast cancer. Results from a phase II study. Breast Cancer Res Treat 1996; 39 (3) : 285-91.
4. Hospira Healthcare Corporation. Monographie de Vinorelbine. Saint-Laurent, Québec. Juin 2007.
5. Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS ; 2014. 58p. Disponible à l'adresse: <http://www.inesss.qc.ca/publications/publications/publication/prise-en-charge-de-letravasation-associee-aux-traitements-antineoplasiques.html>

6. Comité de l'évolution des pratiques en oncologie (CEPO). Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Octobre 2012, 43 pages. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques\\_MAJ\\_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
7. Kornek GV, Kornfehl H, Hejna M, Raderer M, Zochbauer S, Scheuhauer. Acute Tumor Pain in Patients With Head and Neck Cancer Treated With Vinorelbine. JNCI 1996; 88(21) : 1593.
8. Colleoni M, Gaion F, Vicario G, Nelli P, Pancheri F, Sgarbossa G. Pain at tumor site after vinorelbine injection: description of an unexpected side effect. Tumori 1995; 81(3): 194-196.
9. Bragalone DL, Minich SS, Fisher Low J, et al Drug Information Handbook for Oncology, 12<sup>th</sup> ed. Hudson: Lexi-Comp Inc, 2014.
10. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp Inc. Consulté en ligne le 31 mars 2015.
11. Domenech GH, Vogel CL. A Review of Vinorelbine in the Treatment of Breast Cancer. Clinical Breast Cancer 2001; 2(2) : 113-128.
12. Gregory RK, Smith IE. Vinorelbine- a clinical review. British journal of Cancer 2000; 82(12): 1907-1913.
13. Vinorelbine. Dans: DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à l'adresse: <http://www.micromedexsolutions.com> (consulté en ligne le 15 mai 2015).
14. Zelek L, Barthier S, Riofrio M, Fizazi K, Rixe O, Delord JP. Weekly vinorelbine is an effective palliative regimen after failure with anthracyclines and taxanes in metastatic breast carcinoma. Cancer 2001; 92: 2267-72.
15. Ginopoulos P, Mastronikolis NS, Karana A, et al. Use of dexamethasone in the management of phlebitis caused by intravenous administration of vinorelbine (navelbine). Medical Science Research 1998; 26(6):397-398.